

INVESTIGATION PSYCHIATRIQUE

ANAMNÈSE PSYCHIATRIQUE

LA CONDUITE DE L'ENTRETIEN

DÉBUT D'ENTRETIEN

- Se présenter, préciser le cadre temporel et les objectifs :
 - « On va commencer par la présentation...
 - ... Je m'appelle [...] et je suis [...] dans le service de [...]
 - ... L'idée est que l'on fasse un peu connaissance durant 1h et que l'on discute librement de ce qui vous amène/ L'idée est de voir où vous en êtes aujourd'hui / L'idée est de comprendre un peu ce qui se passe/ J'aimerais m'entretenir avec vous sur ce qui vous amène et votre état actuel. Nous avons le temps d'en parler librement.....
 - ... Je vous écoute! »
- Question ouverte:
 - « En quoi puis-je vous aider ? »
 - « Qu'est-ce qui vous amène? »
 - « Qu'est-ce qui vous amène à consulter un psychiatre? »
 - « Pour commencer, je voudrais avoir une idée des problèmes qui vous ont préoccupé au cours du mois qui vient de s'écouler. Quelles ont été vos principales difficultés ? »

EN COURS D'ENTRETIEN

- Le but est de clarifier les éléments apporté par le patient, pour cela il faut :
 1. Reformuler les difficultés décrites et chercher une situation concrète pour analyser les interactions :
 - Donner des détails : « vous voulez m'expliquer en détail ? quand vous dites que vous étiez trop [...], vous pensiez à quoi ? »
 - Donner un exemple : « pouvez-vous me raconter/me faire un exemple ? Pouvez-vous être plus précis ? Dans quelle situation? »
 - Evaluer la réaction : « comment avez-vous réagi à ces propos/cette situation? Vous êtes-vous senti en colère ? Ca vous inquiète ? Si vous êtes en colère qu'est-ce que vous faites ? »
 - Evaluer les capacités/vécus/insight, confrontation: « qu'est-ce qui se passe si vous ne ...? pourquoi cette réaction ? Qu'est-ce que vous avez compris de cette nouvelle? Vous avez une idée sur la cause ? Aujourd'hui vous en êtes là, qu'est-ce que l'on peut faire ? »
 2. Préciser les attentes du patient et les enjeux:
 - « Qu'est-ce qui reste comme difficulté ? »
 - « Pourquoi êtes-vous là? Quels sont les enjeux ? »
 - « Pourquoi consultez-vous maintenant? qu'est-ce qui a changé ? »
 3. Faires des synthèses partielles : « si je vous comprends bien, vous dites que ... »
 4. Interrompre courtoisement : « excusez-moi de vous interrompre, mais je n'ai pas bien compris... »
- Lorsque le sujet donne une information inadéquate:
 - Propos trop brefs : « pouvez-vous me dire davantage de choses à ce propos ? »
 - Le patient n'a rien à ajouter : « y a-t-il d'autres choses qui vous ont troublé ? »

- Propos incompréhensibles : « *pouvez-vous m'expliquer ce que vous entendez par...?* »
- Propos trop vagues : « *pourriez-vous me donner un exemple de...?* »
- Absence de réponse : « *pourquoi êtes-vous venu à l'hôpital/consultation?* »
- Attitude de l'examineur : NEUTRE ET BIENVEILLANTE
C'est-à-dire éviter de prendre position et montrer de l'intérêt pour le récit du patient. Pour cela
 - Éviter les jugements de valeur, même positifs et à but de soutien
 - Montrer son intérêt par des interventions neutres : « *mhhhm* », « *je comprends* », « *c'est possible* », « *en effet* », « *peut-être* ».

EN FIN D'ENTRETIEN

- Faire une synthèse en résumant
- Prendre position sur le plan diagnostique et thérapeutique si la situation est claire et le permet
- Demander au patient si tous les sujets importants ont été abordés et s'il veut ajouter quelque chose.

ANAMNÈSE

- **Motif de consultation**
- **Anamnèse actuelle**
- **Antécédents psychiatriques**
- **Antécédents psychiatrique personnels :**
 - Antécédents d'hospitalisation
 - Suivi psychiatrique ambulatoire
 - Historique de traitements psychotropes
- **Antécédents psychiatriques familiaux :**
 - Présence de pathologies psychiatriques héréditaires ou non
- **Anamnèse socioprofessionnelle et familiale** (soutien par l'entourage)
- **Antécédents médicaux et habitudes** (drogues, médicaments, alcool)

STATUS PSYCHIATRIQUE

Souligné : items importants

Rouge : items important pour l'anamnèse

En gras : items important la classification AMDP

IMPRESSION GÉNÉRALE

Observer :

- Corpulence, tenue vestimentaire :
 - Hygiène
 - Age apparent
 - Tenue soignée / négligée / neutre / excentrique
- Contact et relation :
 - Qualité de la relation instaurée par le patient : superficielle / bonne / mauvaise / froide / bizarre / inquiétante
 - Distance relationnelle instaurée par le patient : patient spontanée / patient ouvert / patient renfermé / patient désinhibé / patient envahissant / patient collant
 - Attitude du patient : patient collaborant / patient passif / patient soumis / patient séducteur / patient méfiant / patient agressif / patient puéril

PSYCHOMOTRICITÉ

Observer le tonus :

- Générale:
 - Ralentissement (inhibition, rigidité, catatonique)
 - Agitation (anxieuse, maniaque, confusionnelle)
 - Parakinésie (tics, tremblements, chorées, dyskinésie)
 - Crise (épileptique, hystérique)
- Visage : amimie, hypermimie, paramimie

TROUBLES COGNITIVES

- **Vigilance** et conscience : observation principalement
 - **Baisse de la vigilance** : degré variable d'endormissement, de ralentissement (de l'obnubilation au coma)
 - **Dissolution de la conscience** : perte de la capacité à comprendre le monde et à se comprendre soi-même, atteinte qualitative de la clarté de la pensée, perte de la capacité à faire des liens, à relier de manière censée
 - **Rétrécissement de la conscience** : focalisation de la pensée, de l'éprouvé et de la volonté sur un nombre réduit de thèmes
 - **Expansion de la conscience** : augmentation/intensification des sensations et des perceptions
 - « Avez-vous l'impression que votre perception est particulièrement intense ? Que vous êtes capable de percevoir les choses avec davantage d'acuité ? Que vous pouvez percevoir les couleurs avec davantage d'intensité ou d'entendre la musique plus fort ? »
-> dépersonnalisation, troubles des perceptions
- **Orientation** : questions directes

« J'aimerais vous poser quelques questions qui pourront éventuellement vous paraître bizarres, mais je vous prie d'y répondre quand-même ».

 - **Temps** : « quelle date sommes-nous aujourd'hui ? Quand êtes-vous entrée dans la clinique ? »
 - **Espace** : « dans quelle ville nous trouvons-nous ? Pourriez-vous me dire où nous nous trouvons ici ? »
 - **Situation** : « que sommes-nous en train de faire ici ? Dans quel genre d'établissement nous trouvons-nous ici ? »
 - **Personne** : « pourriez-vous me donner la date et le lieu de votre naissance et adresse ? Quelle est votre âge/profession/nom ? »
- **Mémoire** et **attention** : observation (sauf si plainte du patient = examen détaillé)

« Maintenant, j'aimerais me faire une idée de votre capacité de concentration et voir avec vous comment votre mémoire fonctionne ».

 - **Troubles de l'aperception** : trouble de la compréhension des perceptions

« Pourriez-vous m'expliquer le proverbe suivant, qu'est-ce qu'il signifie : il n'y a que le premier pas qui coûte ? »
 - **Troubles de la concentration**

« Est-ce que vous arrivez à vous concentrer comme d'habitude ? Avez-vous de la peine à suivre une/cette conversation, à ne pas vous écarter du sujet ? »

« Pourriez-vous compter depuis 81 en déduisant chaque fois le chiffre 4 ? »
 - **Troubles de la fixation** : capacité à se souvenir de nouvelles informations au cours d'une période de moins de 10 minutes

« Est-ce que vous avez actuellement une bonne mémoire ? Avez-vous l'impression d'oublier davantage de choses ? »

« Seriez vous d'accord de faire un petit test de votre mémoire ? Veuillez retenir : **34, Oslo, cendrier**. Je vous les demanderai plus tard. »

- **Trouble de l'évocation** : capacité de se souvenir à long terme, à se souvenir de nouvelles information au cours d'une période de plus de 10 minutes
« Parlez-moi de votre passée/ scolarité / vie professionnelle. »
« Il y a quelques minutes je vous ai proposé 3 mots , est-ce que vous vous en souvenez encore? »
- **Confabulation** : récit imaginaire, spontané ou suggéré (mais vécu comme un souvenir propre) s'exprimant pour compenser une lacune mnésique
Si une question a suscité le doute, la répéter après 15 minutes et comparer la réponse
- **Paramnésie** (fausses impressions) /**hypermnésie** (augmentation de la capacité de mémorisation dans les états fiévreux ou toxiques ainsi que les chocs traumatiques)

LANGAGE

DISCOURS, EXPRESSION VERBALE

Observer :

- Le mode de langage :
 - Dialogue /monologue / soliloque (entretien avec soi-même)
 - Dialogue hallucinatoire / réticence / retenue / inhibition / mutisme
- La forme , le style:
 - Dysphonie : difficulté à émettre des sons et à parler
 - Réduction (diminution) du flux verbal
 - Adjonctions / transformations verbales / transformations phonémique
 - Marmonnements, chuchotements en dehors de la conversation

ELOCUTION

Observer :

- Le débit :
 - Brady/tachy-phémique
 - Laconique / loquace, logorrhéique
- Le ton :
 - Monocorde / exaltée

CONTENU

Observer :

- Incohérence du langage : distorsions grammaticales, pertes de connexion logique, inadéquations soudaines de vocabulaires, formulations grossièrement pédantes
- Fuites des idées
- Pauvreté de contenu du langage
- Réponses déroutantes, erronées

PENSÉE

COURS ET DÉSORGANISATION-DISSOCIATION DE LA PENSÉE

Question d'introduction : *qu'est-ce qui se passe ces temps avec votre faculté de penser ? Parvenez-vous à penser clairement ?*

Demander :

- ↓ de la pensée :
 - **Pensée inhibée** : frein et blocage de la pensée; penser est fatigant
« Avez-vous l'impression que le fait de penser vous fatigue plus que d'habitude ? Parfois on peut avoir l'impression que notre pensée se heurte à une résistance, est-ce que vous connaissez ce phénomène ? »
- ↑ de la pensée :
 - **Ruminations** : préoccupations incessantes, répétitives et désagréables gravitant autour d'un même thème
« Est-ce qu'il arrive que vous pensiez sans cesse à certaines choses ? Avez-vous des pensées qui tournent tout le temps dans votre tête ? Avez-vous tendance à ressasser toujours les mêmes choses ? »
 - **Idées envahissantes** : afflux pressant de multiples pensées
« Avez-vous l'impression d'avoir trop d'idées à la fois ? »

Observer :

- ↓ de la pensée :
 - **Pensée ralentie** : lenteur ou temps de latence dans le déroulement de la pensée
 - **Pensée rétrécie** : réduction de la pensée sur un nombre limité de sujets
« Pouvez-vous prêter attention facilement à des choses simples ? Est-ce que vos pensées ont tendance à être ralenties ou embrouillées ? »
 - **Persévération** verbale : répétition de mots ou de phrases
 - **Pensée circonstanciée** : discours minutieux (cohérence et le fil de la pensée préservés) chargée de détails inutile (difficulté à distinguer l'essentiel de l'accessoire)
 - **Réponses à côté** : perte du fil de la pensée avec des changements de buts. -> le patient n'arrive pas à terminer ses phrases parce que sa pensée est parasitée par d'autres idées. Il faut s'assurer que le patient a bien compris la question en lui demandant de la répéter.
 - **Pensée barrée** : suspension brusque du cours de la pensée
« Avez-vous parfois l'impression que le cours de votre pensée se perd ou qu'il s'interrompt ? »
- ↑ de la pensée :
 - **Fuite** des idées ou **pensée digressive**
« Avez-vous été capable de vous concentrer ces derniers temps ? »
 - **Néologismes** : utilisation de mots non compréhensibles ou nouvellement créés.
- ---> discontinuité de la pensée :
 - **Pensée incohérente** : perte de logique, pensée disloquée ou incompréhensible
 - Réponse à côté, coq à l'âne
 - Jeux de mots, calembours, mots assonancés, contamination
 - Ellipse (omettre un ou plusieurs éléments en principe nécessaires à la compréhension), relâchement associatif, condensation (« résumé de la pensée »)

CONTENU DE LA PENSÉE

Observer : les thématiques et les informations

- La capacité d'abstraction et de causalité :
 - Contenu asymbolique, alexithymique, rétrécie, rationnel
 - Contenu syncrétique (appréhension globale, floue, non structurée de la réalité), paralogique, morbide
 - Contenu magique
- Les idées délirantes
- Les idées obsédantes, les ruminations

DÉLIRE, TROUBLES DU MOI ET DES PERCEPTIONS

DÉLIRE

- Démarche :
 - Phrase- de départ :
Avez-vous vécu ces derniers temps des choses bizarres qui vous ont inquiété ou qui vous ont même fait peur ?
 - Chercher des indices : s'il y a un soupçon de symptômes délirants, il faut investiguer également leur contenu -> item : idées délirantes
 - Confrontation : pour vérifier si la conviction subjective (≠ questionnement critique) du patient est délirante ou non, il faut lui proposer des explications rationnelles alternatives et analyser sa réaction.
- Vécu prédélirant : demander
 - **Pressentiment délirant** : atmosphère bizarre ou anormale
Avez-vous l'intuition qu'il va vous arriver quelque chose, que tout est inquiétant, qu'il se trame quelque chose ?
 - **Perception délirante** : attribution d'un sens erroné à une perception normale existante
Existe-t-il dans votre entourage des choses particulières qui ont une signification spéciales ou privée et qui ne concerne que vous ? Est-ce que tous les feux sont verts exprès pour vous ?
 - **Intuition délirante** : conviction délirante non rattachée à une perception existante/normale
« Est-ce que cette idées vous est venue subitement à l'esprit ou est-ce que vous la connaissez depuis longtemps ? Etes-vous convaincu de ne pas vous tromper ? »
- Vécu délirant : observer et demander
 - **Idées délirantes non systématisées**
 - **Systématisation du délire** : degré d'organisation du délire, liens entre les délires
« Voyez-vous un quelconque rapport/lien entre ces choses ? Pourriez-vous me l'expliquer ? »
 - **Dynamisme du délire** : investissement affectif du délire
- Idées délirantes : À INVESTIGUER SI SOUPÇON DE DÉLIRE!!!
 - **Idées délirantes de référence** : les événements fortuits sont ramenés/interprétés en référence à soi
« Avez-vous l'impression que beaucoup de choses qui se passent autour de vous ont une signification qui vous concerne ? Est-ce que les déclarations, par exemple à la télévision, vous sont adressées personnellement ? Les gens font-ils des allusions à votre sujet ou tiennent-ils des propos à double sens ? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas ce qu'ils semblent être ? »

- **Idées délirantes de préjudice ou de persécution :**
« Avez-vous l'impression que certaines personnes/quelqu'un vous en veulent/veut, que certaines personnes/quelqu'un ont/a l'intention de vous faire du mal ? Est-ce que l'on essaie délibérément de vous faire du mal ? Comment ? »
- **Idées délirantes de jalousie :**
« Avez-vous l'impression que votre partenaire ne vous est pas fidèle ? Qu'est-ce qui vous permet de le déduire ? Avez-vous des raisons d'être jaloux ? »
- **Idées délirantes de culpabilité :**
« Est-ce que vous vous sentez responsable de certaines choses ou certains actes ? Avez-vous le sentiment que vous vous êtes rendus coupable ? »
- **Idées délirantes de ruine :**
« Pourrez-vous me donner quelques renseignements sur vos revenus ? Est-ce que votre argent/moyen suffit pour vous nourrir, pour vous habiller et pour les autres choses dont vous pouvez avoir besoin ? »
- **Idées délirantes hypocondriaques :**
« Avez-vous peur d'être atteint d'une maladie grave que les médecins n'ont pas découverte ? Avez-vous l'impression que votre corps ne fonctionne pas de manière satisfaisante ? Pouvez-vous croire que vous êtes en bonne santé physique si les médecins vous le disent ? »
- **Idées délirantes de grandeur :**
« Avez-vous l'impression de disposer de facultés extraordinaires ? Avez-vous par exemple, l'impression d'être le fils ou la fille d'autres personnes que des parents que vous avez ? »
- **Autres contenus délirant :** délires fantastiques

TROUBLES DES PERCEPTIONS

- Démarche :
 - ATTENTION, il faut explorer prudemment et éviter les questions du type « est-ce que vous entendez des voix ? »
 - Demander
 - Question d'introduction :
« Y a-t-il quelque chose qui vous angoisse ou qui distrait ? »
« Y a-t-il quelque chose qui vous influence de façon déroutante ou inquiétante ? »
« Je voudrais vous poser une question de routine que je pose à tout le monde. est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir des visions ou des expériences inhabituelles, comme en ont parfois certaines personnes ? »
- **Illusions** : représentation déformées correspondant à un stimulus réel (arbre mort le long d'une route au crépuscule perçu comme un individu menaçant) -> s'il y a des indices dans le discours du patient, lui demander des précisions
- **Hallucinations** : perception sans stimulus réel
 - Hallucination **acoustico-verbales** :
« Vous arrive-t-il parfois d'entendre parler quelqu'un, bien qu'il n'y ait personne dans les environs immédiats ? D'autres personnes l'entendent ? S'agit-il d'un homme, d'une femme, d'une voix familières ? Que vous dit-elle ? Est-il possible qu'il ne s'agisse que de vos propres pensées qui font écho en vous ? »
 - Hallucinations **auditives** :
« Vous est-il arrivé d'entendre autre chose ? Par exemple des bruits, des sons ? »
 - Hallucination **visuelles** :

« Vous est-il arrivé de voir des personnes ou des objets qu'autrui ne pouvait voir ? Pourriez-vous préciser ? »

- Hallucination **cénesthésiques** : perception de frôlement, de caresse ou de piqures, de brûlures, de pincement douloureux
« Y a-t-il des choses bizarres qui se passent dans votre corps ? avez-vous l'impression que quelque chose dans votre corps a changé ? Si oui, comment vous en rendez-vous compte ? »
- Hallucination **olfactives** et **gustatives**
« Avez-vous senti des odeurs bizarres ces derniers temps ? Ou est-ce que la nourriture et les boissons ont un autre goût que d'habitude ? »
- Pseudo-hallucination

TROUBLES DU MOI

- Définition : altération de la manière de s'éprouver soi-même, les autres ou l'environnement, perte de familiarité
- Démarche :
 - ATTENTION, il est important d'explorer prudemment et précautionneusement les troubles du moi. Le patient peut ne pas en parler et se montrer méfiant, anxieux et fortement désécurisé par la mise en doute de son vécu.
 - Demander
 - Question d'introduction :
« Avez-vous par exemple observé ces derniers temps que vous ou votre entourage avez changé d'une manière quelconque ? J'aimerais vous demander si vous avez constaté un changement quelconque dans votre vécu ou dans votre entourage ? en quoi consiste ce changement ? Pourriez-vous le décrire ? »
- **Déréalisation** ou étrangeté : perte de familiarité par rapport à l'environnement
« Ces derniers temps, votre environnement habituel vous paraît-il déformé ou étrange ? Votre perception du monde / les couleurs / l'intensité de la musique que vous écoutez / les aliments a-t-elle changé ? »
- **Dépersonnalisation** : perte de familiarité par rapport à soi, sentiment de ne plus être soi-même
« Percevez-vous votre corps comme d'habitude ? Avez-vous la sensation que votre corps s'est physiquement transformé ? Avez-vous l'impression d'avoir complètement changé, de ne plus être la même personne qu'avant ? »
- **Dévinement de la pensée** : d'autres personnes participent dans l'élaboration des pensées du patient ou bien savent ce que le patient pense. Les pensées n'appartiennent plus au patient.
« Croyez-vous qu'autrui connaît vos pensées ? Qu'autrui peut savoir ce que vous êtes en train de penser ? Pouvez-vous me donner un exemple ? »
- **Vol de la pensée** : pensées enlevées ou prélevées
« Avez-vous l'impression qu'on peut vous prendre vos pensées ? »
- **Pensées imposées** : pensées influencées, gouvernées, suggérées par l'extérieur
« Avez-vous parfois le sentiment que vos pensées ne vous appartiennent pas, que vos pensées sont induites de l'extérieur ? Avez-vous l'impression qu'on influence et qu'on dirige vos pensées ? »
- **Autres expériences d'influence** : sentiments, décisions imposées par l'extérieur
« Il y a des personnes qui ont parfois le sentiment d'être hypnotisées ou quasiment téléguidées, est-ce que vous connaissez également ce sentiment ? Pouvez-vous me donner un exemple ? »

AFFECTS (ÉMOTIONS OBSERVÉES) ET TROUBLES AFFECTIFS

AFFECTS

- **Thymie** : demander
 - Humeur abaissée/élevée/neutre
« Comment définiriez votre humeur ? Vous vous sentez plutôt triste, heureux, sans changements ? »
 - Humeur :
 - Apathique, triste, anesthésiée
 - Joyeuse, euphorique, exaltée, avec un sentiment de puissance
 - Anxieuse, angoissée, apeurée
 - Colérique, agressive, méfiante
 - Avec un sentiment de culpabilité
- Symptômes d'accompagnement : demander
 - **Anhédonie** : « est-ce que vous avez moins de plaisir à faire les choses ? »
 - Perte **d'appétit** : « avez-vous eu bon appétit ces derniers temps ? »
 - Trouble du **sommeil** : « avez-vous eu des difficultés à vous endormir ce mois dernier ? Vous réveillez-vous trop tôt le matin ? »
 - Manque d'énergie : « avez-vous l'impression de manquer d'énergie, d'être plus lent dans vos mouvements ? »
 - Libido abaissée : « avez-vous constaté un changement dans vos intérêts sexuels ? »
- **Modulation** : observer
 - Affects congruents à l'humeur / discordance affective
 - Labilité affective

TROUBLES AFFECTIFS ET ANXIÉTÉ

- **Perplexité** : difficulté à se situer par rapport aux événements sur le plan affectif
« J'ai l'impression que vous avez perdu la vue d'ensemble de la situation, est-ce vrai ? J'ai actuellement l'impression que vous ne savez pas tout à fait ce qui se passe, est-ce vrai ? »
- **Anesthésie affective** : demander et observer !
« Est-ce que votre vie affective a changé d'une manière ou d'une autre ? Etes-vous encore capable d'être triste ou de vous réjouir ? Ou vous avez plutôt le sentiment d'être vide /mort intérieurement ? »
- **Trouble de l'éprouvé vital** : diminution de la vitalité, de l'élan, de la force physique et psychique
« Avez-vous la sensation d'une diminution de votre vitalité, de votre élan et de votre fraîcheur ? Avez-vous une impression d'abattement, de faiblesse, de fatigue ? »
- **Humeur déprimée** : humeur de tonalité négative, déprimé, abattu
« Comment vous sentez-vous actuellement ? Comment pourriez-vous décrire votre humeur actuelle ? Etes-vous triste ? »
- **Perte de l'espoir** : pessimisme, incapacité à se projeter dans l'avenir
« Quelles sont vos réflexions lorsque vous pensez à votre avenir ? Quelle est votre attitude à l'égard de l'avenir ? Pouvez-vous imaginer que tout va s'arranger ? Quand vous vous tournez vers l'avenir, croyez-vous que votre état s'améliorera ? »
- **Anxiété psychique éprouvée** : peur sans pouvoir dire quoi
« Vous inquiétez-vous en ce moment plus que d'habitude ? Pouvez-vous me donner un exemple ? Avez-vous peur parce que vous craignez qu'un malheur arrive ? »
- **Euphorie** : humeur de tonalité positive, bien-être excessif
« J'ai l'impression que vous êtes spécialement de bonne humeur aujourd'hui, est-ce que c'est vrai ? »
- **Dysphorie** : mauvaise humeur, agacement, grincheux, bougon
« J'ai l'impression que vous êtes de mauvaise humeur. Est-ce que c'est vrai ? »

- **Irritabilité** : excitabilité, tension forte
« Je ressens actuellement une certaine irritation chez vous, est-ce que c'est vrai ? »
- **Agitation intérieure** : fébrilité intérieure, nervosité
« Pourriez-vous me décrire comment vous vous sentez intérieurement ? Vous sentez-vous agité intérieurement ? »
- **Propension à se plaindre** : lamentation
- **Sentiment d'insuffisance**
« Comment jugez-vous vos propres capacités ? Avez-vous l'impression que vous valez moins qu'autrui/ de ne rien valoir/d'être incapable et stupide ? »
- **Augmentation de l'autosatisfaction**
« Avez-vous un sentiment particulier de force et d'augmentation de vos performances ? »
- **Sentiment de culpabilité**
« Il arrive parfois que des patients se sentent tout à coup coupables de certains événements qui se sont passés il y a déjà bien des années et pour cette raison ils ont une mauvaise conscience. Cela vous arrive-t-il également ? de quelle nature sont-ils ? »
- **Sentiment de ruine** : crainte de ne pas disposer de moyens suffisants pour subvenir à son existence
« Avez-vous peur qu'il vous manque les moyens de subvenir à votre existence ? »
- **Ambivalence affective** : coexistence pénible de plusieurs sentiments et représentations contradictoires
« Vous arrive-t-il de vivre des sentiments contradictoires simultanément ou que des pensées contradictoires coexistent en vous ? »
- **Discordance affective** ou parathymie : affects paradoxaux inadéquats
- **Labilité affective** : changement émotionnels rapides, instabilité psychique
- **Incontinence affective** : émergence d'émotions incontrôlables voire disproportionnées
- **Monotonie affective** : réduction de la capacité à moduler, à faire osciller ses affects.

TROUBLES ANXIEUX (PHOBIES, OBSESSIONS, IMPULSIONS, COMPULSIONS)

- **Méfiance non délirante** : attitude soupçonneuse tantôt anxieuse, tantôt hostile avec une tendance à douter de la bonne foi des autres
« Ressentez-vous ces derniers temps une certaine méfiance vis-à-vis autrui ? Par le passé, vous décririez-vous comme plutôt une personne méfiante que crédule ? »
- **Hypocondrie non délirante** : angoisse/crainte non fondée d'avoir ou de contracter une maladie
« Avez-vous peur d'être atteint d'une maladie grave ? Avez-vous l'impression que quelque chose ne fonctionne pas dans votre corps ? avez-vous déjà fait des démarches pour trouver ce qui ne fonctionne pas ? »
- **Phobies** : peur de certaines situations, objets, animaux admise comme irrationnelles qui donnent lieu à des conduites d'évitement
« Vous arrive-t-il de prendre peur, voire même de paniquer face à certaines situations concrètes ? tentez-vous de les éviter ? »
- **Obsessions** : idées qui s'imposent de manière répétée et qui sont vécues comme absurdes et contre sa propre volonté
« Est-ce que vous avez des idées particulières qui s'imposent à vous de façon automatique et qui tournent tout le temps dans votre tête (et qui vous paraissent irrationnelles) ? »
- **Obsessions-impulsions** : idées qui s'imposent et poussent à des actes bien définis
« Ressentez-vous des pulsions répétitives à exécuter des actes particuliers et craignez-vous de les accomplir une fois ? Vous sentez-vous poussé à répéter continuellement certains gestes ou actes particuliers ? »
- **Compulsions** : conduites (actions) sous l'effet d'impulsions internes

« Vous sentez-vous forcé de répéter sans cesse certaines actions, bien quelles vous paraissent irrationnelles ? »

TROUBLES SOMATIQUES ET DU DYNAMISME

« Maintenant, j'aimerais vous demander comment vous jugez votre élan et votre initiative à faire certaines choses. ».

- **Diminution du dynamisme ou de l'entrain/vitalité** : manque d'énergie, d'entrain
- **Inhibition du dynamisme** (frein) :
- **Augmentation du dynamisme**
- **Agitation motrice**
- **Parakinésie** : anomalies qualitatives des mouvements complexes
- **Maniérisme** ou bizarreries : gestes et actes quotidiens apparaissant comme bizarres, sugrenus artificiels ou prétentieux
- **Théâtralisme** : impression que le patient se donne lui-même en représentation
- **Laconisme** : parcimonie verbale
- **Logorrhée** : augmentation du flux verbal

IDÉES SUICIDAIRES ET HÉTÉRO-AGRESSIVITÉ

- Attention, NE PAS EVALUER LA SUICIDALITE EST CONSIDERE COMME UNE FAUTE MEDICO-LEGALE!
- Question explicites :
 - « Est-ce que vous avez par moments des idées noires ou des envie de vous faire du mal ? »
 - « Est-ce que cela vous arrive d'avoir envie de mourir ? »
 - « Avez-vous déjà pensé à vous suicider ? »
- Critères de gravité à évaluer
 - Facteur de risque épidémiologique à dépister :
 - Antécédents de tentatives ;
 - Sexe masculin ;
 - Trouble psychiatrique ;
 - Dépendance ;
 - Isolement social et familial ;
 - Evénements de vie négatifs ;
 - Maladie chronique ;
 - Affection somatique invalidante.
 - Urgence si :
 - Elaboration d'un scénario suicidaire ;
 - Les idées suicidaires sont envahissantes ;
 - Planification dans le temps du geste suicidaire.
 - Danger si :
 - Le moyen est accessible ;
 - Le moyen est très létale.